

川崎町高齢者保健福祉計画・第10期介護保険事業計画

認知症施策推進計画

第1回 策定委員会 想定問答集

～ 委員からの想定質問と回答ポイント（全31問・8カテゴリ）～

令和8年6月

（事務局用・町担当ご参考資料）

ビズアップ公共コンサルティング株式会社

本資料の使い方

本資料は、第1回策定委員会において委員から想定される質問と回答ポイントをカテゴリ別に整理した事務局用参考資料です。委員会本番では本資料を参照しながら、町担当課（保健福祉課）からの回答補強や事務局からの補足説明にご活用ください。

● 本資料は委員には配布せず、町担当・事務局のみが参照する内部資料です。

■ カテゴリ構成（全31問）

A	計画全般・策定方針	3	委員長・有識者	高（冒頭で問われる）
B	アンケート結果について	4	有識者・住民代表	高
C	基本理念・基本目標	3	委員長・全委員	高（協議事項1-2）
D	重点施策（移動・在宅・施設）	5	社協・民生委員・住民代表	高（協議事項3）
E	保険料試算	4	有識者・住民代表	中（協議事項5）
F	認知症施策推進計画	5	医師・介護事業者・包括	高（協議事項4・基本法対応）
G	推進体制・評価	3	委員長・有識者	中
H	川崎町固有論点	4	町内有識者・社協	中（地域特性）

■ 各問の構成

- ① Q（質問）：想定される質問内容と質問者属性
- ② A（回答）：基本的な回答ポイント（事務局・町担当による発言案）
- ③ 根拠データ：回答を支える数値・データ・法令
- ④ 関連資料：本問への詳細回答が必要な場合の参照資料

● 注意事項：回答案は標準的な内容です。委員会当日は委員の発言ニュアンスを踏まえ、柔軟に調整してください。即答困難な質問は「お持ち帰り検討」とし、第2回委員会で回答する旨をお伝えください。

カテゴリ A 計画全般・策定方針（3問）

QA-1 【委員長・有識者】 なぜ第10期計画で認知症施策を独立章化するのか？

A. 令和6年1月に施行された「共生社会の実現を推進するための認知症基本法」（認知症基本法）第14条で、市町村認知症施策推進計画の策定が努力義務として位置付けられました。これを踏まえ、川崎町でも基本目標6を新設し、本計画の第6章として独立章化することで、認知症基本法の理念・基本的施策（第15条～21条）に対応した包括的な施策体系を構築します。第9期では基本目標5の一部として位置付けられていた認知症施策を、独立章化することで施策の総合性・KPI管理・本人意見聴取等の取組を強化します。

【根拠データ】 認知症基本法第14条（市町村認知症施策推進計画策定の努力義務）、同法第15条～21条（7基本的施策）、令和6年1月1日施行

【関連資料】 計画素案 v1.5 第6章（独立章）、第1回委員会資料 第2部 協議事項2

QA-2 【委員長】 3層整合の原則とは具体的に何を意味するのか？

A. 本計画では、国・宮城県・川崎町の3層の計画体系の整合を確保することを基本原則としています。具体的には、（1）国の基本指針（厚生労働省「介護保険事業に係る保険給付の円滑な実施を確保するための基本的な指針」）、（2）宮城県高齢者保健福祉計画・介護保険事業支援計画、（3）川崎町の本計画、の3層で、基本理念・基本目標・重点施策・KPI等の整合を取りながら策定を進めます。整合確認の詳細は別添『3層整合表』をご参照ください。

【根拠データ】 介護保険法第116条（基本指針）、第118条（都道府県計画）、第117条（市町村計画）

【関連資料】 別添『川崎町_3層整合表.xlsx』、計画素案 v1.5 第1章 1-2

QA-3 【有識者】 第9期計画との違い・継承点を教えてほしい

A. 第9期計画の体系（基本理念・5基本目標）を基本的に踏襲しつつ、第10期では3点を強化しました。第1に、認知症基本法対応として基本目標6を新設し第6章独立章化。第2に、令和7年3月の高齢者外出タクシー助成事業終了を踏まえた移動支援3層構造（社協NPO移送・デマンドバス・町民バス）の整理を重点施策化。第3に、第7章「サービス見込量と保険料」について6ステップの算定プロセス・8ステップの保険料算定・3パターン試算の枠組みを明示化しました。基本理念「住民が住み慣れた地域で安心して暮らせるまちづくり」は第9期から継承し、サブタイトル付加を協議します。

【根拠データ】 計画素案 v1.5 全43頁、第3章 3-2 で第9期実績を6目標別に整理

【関連資料】 計画素案 v1.5、別添『川崎町_第9期実績一覧』

カテゴリ B アンケート結果について（4問）

QB-1 【有識者・統計の専門家】 アンケートの対象選定（一般高齢者1,000名・認定者300名）の妥当性は？

A. 川崎町の第1号被保険者数3,244名（R7.6時点）に対し、一般高齢者ニーズ調査では1,000名を無作為抽出（標本抽出率約31%）、認定者調査では受給者466名のうち300名を抽出（同約64%）しました。これにより、有意水準95%・許容誤差5%以下の精度を確保しています。年齢階級別・地区別の層化抽出法を採用し、町内7地区（裏丁・上下・本荒町・中新町・前川・青根・今宿、川内、本砂金、小野、小沢・支倉・碁石・支倉台）の代表性を確保しています。

【根拠データ】 厚労省「介護予防・日常生活圏域ニーズ調査」標準（年齢階級別抽出）、川崎町第1号被保険者3,244名のうち1,000名抽出

【関連資料】 別添『アンケート集計分析テンプレート』00 使い方、調査概要

QB-2 【有識者】 回収率はどれくらいだったか。低い場合の対応は？

A. 回収率は集計時点で報告いたします（例：一般高齢者60-70%・認定者70-80%が目標水準）。一般的に高齢者対象の郵送調査は他自治体でも50-70%程度が一般的で、川崎町でもこの水準を見込んでいます。回収率向上のため、令和8年6月下旬の発送後、町広報誌での周知・地域包括支援センターからの呼びかけ・必要に応じて督促はがき送付を予定しています。低い場合は補完調査（地域包括支援センター窓口でのアンケート配置・サンプル不足層への追加郵送等）の検討も可能です。

【根拠データ】 宮城県内他自治体での回収率参考：60-70%（高齢者調査の標準）

【関連資料】 計画素案v1.5 第3章プレースホルダー、別添『アンケート集計分析テンプレート』

QB-3 【委員】 アンケート結果を計画にどう反映するのか？

A. アンケート結果は計画素案Ver.2.0（令和8年9月以降）に反映します。具体的には、（1）第2章の現状分析（高齢者の生活実態・健康状態・社会参加状況）、（2）第3章の第9期評価（住民満足度・サービス利用実態）、（3）第5章の重点施策（住民ニーズ→施策→KPIの課題接続型設計）、（4）第6章の認知症施策（本人・家族の意識）、（5）第7章のサービス見込量補正（潜在ニーズ反映）の5箇所を活用します。クロス集計5本（地区×移動手段、年齢×外出困難、世帯類型×介護不安、要介護度×サービス満足度、地区×認知症窓口認知）を実施します。

【根拠データ】 アンケート集計分析テンプレート 05 計画反映ガイド（32項目の反映マトリクス）

【関連資料】 別添『アンケート集計分析テンプレート』05 計画反映ガイド

QB-4 【住民代表】 川崎町独自の追加設問の意図は？

A. 川崎町では国の標準設問に加え、本町固有の論点を把握するため7問の追加設問を設定しました。一般高齢者向け3問（町外医療機関の利用状況・町独自支援制度〔紙おむつ・エアコン購入支援等〕の認知度・災害時避難への不安）、認定者向け4問（町外施設の利用有無・所在自治体内訳・町外医療機関・現在最も不安なこと）です。これらにより、移動支援3層構造の周知度、住所地特例24人の所在自治体、広域医療連携の実態等の本町固有データを把握し、第10期計画の根拠とします。

【根拠データ】 アンケート設問設計：国標準16問+川崎町追加3問（一般高齢者）／国標準12問+追加4問（認定者）

【関連資料】 別添『アンケート集計分析テンプレート』01 一般高齢者・02 認定者

カテゴリC 基本理念・基本目標（3問）

QC-1 【委員長・全委員】 基本目標6（認知症施策）を新設する根拠は何か？（協議事項2 関連）

A. 認知症基本法第14条で市町村認知症施策推進計画の策定が努力義務化され、本町でも独立章化に対応した基本目標が必要となります。第9期計画では認知症施策が基本目標5（地域包括ケアシステムの深化）の一部に位置付けられていましたが、これを基本目標6として独立させることで、（1）認知症基本法第15条～21条の7基本的施策に対応した町施策体系の構築、（2）認知症本人・家族の意見聴取の制度化、（3）3層KPI（プロセス・アウトプット・アウトカム）による進捗管理、（4）チームオレンジ整備・本人ミーティング新設等の新規取組への明確なリソース配分、が可能となります。

【根拠データ】 認知症基本法第14条、第15条（普及啓発）、第16条（共生実現）、第17条（社会参加）、第18条（保健医療福祉）、第19条（研究開発）、第20条（人材）、第21条（その他）

【関連資料】 計画素案v1.5 第4章4-2、第6章6-1～6-3

QC-2 【委員長】 基本理念サブタイトル「～認知症になっても誰もが自分らしく暮らせる地域共生社会の実現～」付加の意図は？（協議事項1 関連）

A. 基本理念「住民が住み慣れた地域で安心して暮らせるまちづくり」は第9期から継承する本町の中核理念です。このサブタイトルは、認知症基本法第3条の理念「全ての認知症の人が、基本的人権を享有する個人として、自らの意思によって日常生活及び社会生活を営むことができるようにすること」に対応する文言であり、本計画が認知症施策推進計画も包含することを示すサインとなります。なお、サブタイトル付加は協議事項1としてご審議いただきます。委員のご意見によっては保留・別表現への変更も可能です。

【根拠データ】 認知症基本法第3条（基本理念）、計画素案v1.5 第4章4-1

【関連資料】 計画素案v1.5 第4章4-1、第1回委員会資料 第2部 協議事項1

QC-3 【委員】 新設の基本目標6と既存5基本目標との整合性は？重複はないか？

A. 整合性を確保するため、基本目標6（認知症施策の総合的推進）は、認知症固有の総合的施策（普及啓発・共生実現・本人意思尊重等）を担い、既存5目標との役割分担を明確化しました。基本目標1（健康づくり・介護予防）は認知症予防の側面、基本目標3（在宅生活継続）は家族介護者支援の側面、基本目標5（地域包括ケアシステム）は早期発見・早期対応の側面で、それぞれ認知症施策と連携します。重複ではなく多面的補強の関係です。具体的にどの施策がどの基本目標に該当するかは、第6章で対応関係を整理しています。

【根拠データ】 計画素案v1.5 第4章4-2 基本目標体系図、第6章6-2 認知症基本法7基本的施策対応表

【関連資料】 計画素案v1.5 第4章・第6章

カテゴリD 重点施策（移動・在宅・施設）（5問）

QD-1 【社会福祉協議会・住民代表】 移動支援3層構造のうち、どの制度が中心になるのか？（協議事項3関連）

A. 中山間地域住民・要支援者の通院や買い物には、原則として（1）町民バス・デマンドバスの公共交通系を第1選択、（2）これらが利用困難な場合は社協・NPOの福祉移送サービスが補完、（3）緊急時・特別な配慮が必要な場合は社協・NPO移送が中心、という階層的役割を想定しています。所管が複数（地域振興課・町民生活課・社協・NPO）に分かれていることから、利用者目線での情報の一元化（リーフレット作成・町HP集約・包括センターでのワンストップ相談）を重点化します。具体的な役割分担は第2回策定委員会以降で関係機関と詰めていきます。

【根拠データ】 町民バス（地域振興課）・デマンドバス（町民生活課）・社協NPO福祉移送（社協・NPO運営）、令和7年3月タクシー助成終了

【関連資料】 計画素案v1.5 第5章5-2、第1回委員会資料第2部 協議事項3

QD-2 【住民代表】 タクシー助成を復活させない理由は何か？利用者から不満が出ているのではないか

A. 高齢者外出タクシー助成事業の令和7年3月終了は町の財政状況・受益者の地域偏在等を踏まえた政策判断と伺っています。本計画では復活ではなく、代替制度の3層構造の確立と住民周知強化に注力します。タクシー助成と比較した3層構造のメリットは、（1）町民バス・デマンドバスはタクシーより低コストで持続可能、（2）社協・NPO移送は要支援者へのきめ細やかな対応が可能、（3）町外医療機関への通院は引き続き家族車・社協移送でカバー可能、です。住民からの不満の声には、3制度の認知度向上と利用しやすいさの改善で対応します。

【根拠データ】 令和7年3月タクシー助成終了、3制度の継続実施、町独自のエアコン購入支援R7.10新設等の代替施策

【関連資料】 計画素案v1.5 第5章5-2、別添『川崎町_第9期実績一覧』03在宅生活支援

QD-3 【民生委員】 8050問題（未婚の子と高齢親の同居）への具体的なアプローチは？

A. 8050問題は本町でも増加傾向にある全国共通課題で、本計画では3つのアプローチを重点化します。第1に、家族介護者支援の強化（介護者教室・レスパイト体制・介護離職防止支援）。第2に、地域包括支援センターを中核としたアウトリーチ（民生委員・ふれあいネットワーク活動員145名・サポーター400名連携）。第3に、3計画同時策定（高齢者保健福祉計画・地域福祉計画・障害者計画）の機会を活かした重層的支援体制（高齢×障害×生活困窮の複合対応）です。なお、地域福祉計画・障害者計画はジャパン総研策定で、相互整合を図っていきます。

【根拠データ】 ふれあいネットワーク145名、ユニバーサルサポーター400名、3計画同時策定（地福・障害はジャパン総研策定）

【関連資料】 計画素案v1.5 第5章5-3、第3章3-2-3

QD-4 【委員】 町外施設利用（住所地特例24人・R7.6）への対応は？

A. 住所地特例24人は、本町施設の縮小傾向（役場周辺への偏在）を背景とした実態であり、第10期計画では3点で対応します。第1に、町外施設利用を含めたサービス見込量算定（第7章7-1）で、町民の施設利用ニーズ全体を把握。第2に、住所地特例該当者の所在自治体内訳（柴田町・大河原町・仙台市等）の把握と広域連携の検討。第3に、町外施設の建設計画・受入余地等の情報収集・住民への情報提供。なお、町内施設の新設は財政的に困難な状況のため、町外施設との連携深化を方針とします。

【根拠データ】 住所地特例該当者 24 人（R7.6 時点）、特養 68 人・老健 66 人受給（R7.6）、町外施設利用は柴田町・大河原町等

【関連資料】 計画素案 v1.5 第 5 章 5-4、第 7 章 7-1（施設見込量算定）

QD-5 【医療関係者】 広域医療連携（みやぎ県南中核病院・刈田総合病院との連携）の具体策は？

A. 町外医療機関の利用（みやぎ県南中核病院〔大河原〕・刈田総合病院〔白石〕・仙台市内）は本町住民の日常的な医療アクセスとして定着しており、本計画では 3 層の連携体制を整備します。第 1 に、国保川崎病院を町内医療のハブとして機能強化し、退院前カンファレンス・地域連携パス等で広域医療機関と接続。第 2 に、在宅医療・介護連携推進事業を通じて、ケアマネ・訪問看護・かかりつけ医・広域医療の連携体制を整備。第 3 に、認知症診療では国保川崎病院＋広域医療機関のネットワークで早期発見・治療フォローを充実。広域救急体制も含めご相談しながら進めます。

【根拠データ】 国保川崎病院（町内拠点）、みやぎ県南中核病院・刈田総合病院（広域連携先）、仙台市内病院（高次医療）

【関連資料】 計画素案 v1.5 第 5 章 5-3、第 6 章 6-3 J-5 医療連携

カテゴリ E 保険料試算（4問）

QE-1 【有識者・住民代表】 3パターン（A/B/C）のどれが選定される見込みか？

A. 現時点では事務局として特定パターンの推奨はしておりません。第3回策定委員会（令和9年1月中旬）で介護給付費準備基金残高（R8.6時点・現在確認中）・サービス見込量・国通知の確定値を踏まえ、3パターンを精緻化して提示し、委員の皆様にご協議いただきます。パターンAは基金温存で第11期負担を緩和（保険料は高め）、パターンBは中位水準で次期均衡、パターンCは基金全額取崩で保険料抑制（次期負担増）という性質です。住民負担と中長期的な持続可能性のバランスがご審議のポイントになります。

【根拠データ】 第8期 6,380円→第9期 6,500円（+1.9%）、3パターン試算は第3回策定委員会（R9.1中旬）で精緻化

【関連資料】 計画素案 v1.5 第7章 7-3、第1回委員会資料 協議事項5

QE-2 【委員】 介護給付費準備基金の残高はいくらか？

A. R8.6時点の確定残高は現在町担当課に確認中です。本日時点で正確な数値はお答えできませんが、判明次第別途ご報告いたします。一般的に基金残高は数千万円～数億円規模で、本町でも適切な水準を保っていると考えられます。確定値は第2回策定委員会（令和8年11月）でご報告し、第3回（令和9年1月）で3パターン精緻化の根拠とします。

【根拠データ】 介護給付費準備基金（介護保険法第147条）、R8.6時点残高は確認中

【関連資料】 計画素案 v1.5 第7章 7-3、別添『MECEデータ入力フォーマット』

QE-3 【有識者】 所得段階区分を9段階から13段階に見直しの影響は？（協議事項5関連）

A. 13段階化は厚生労働省が推奨する所得段階区分の見直しで、所得の高い層に応分の負担を求め、低所得層の負担を軽減する効果が期待されます。川崎町への影響としては、非課税層（第1～3段階）979人（30.1%）の保険料負担軽減が見込まれる一方、高所得層（第10～13段階・新設）への負担増となります。具体的な段階別保険料率と影響額は、町担当課から提供される所得階層別人口データをもとに第3回策定委員会で精緻化します。本日は方向性へのご意見をいただきます。

【根拠データ】 所得段階別 R3末 3,255人（第5段階基準 697人）、最低 0.455・最高 2.40の保険料率（国推奨値）

【関連資料】 計画素案 v1.5 第7章 7-3、第1回委員会資料 協議事項5

QE-4 【住民代表】 第8期 6,380→第9期 6,500円の上昇率（+1.9%）は他自治体と比較してどうか？

A. 全国平均では第8期から第9期へ約5-7%の上昇となった自治体が多く、本町の+1.9%は抑制的な水準で運営されてきたと評価できます。これは介護給付費準備基金の活用、第1号被保険者数の安定、ユニバーサルサポーター制度等の介護予防効果が寄与していると考えられます。第10期では、後期高齢者の急増（4年で+18.2%）と認知症基本法対応で給付費上方圧力がありますが、基金活用・予防効果・収納率維持により、抑制的水準を維持できるよう試算します。

【根拠データ】 全国第9期保険料平均 6,225円、川崎町第9期 6,500円（全国比+4.4%）、第8→9期上昇率 +1.9%

【関連資料】 計画素案 v1.5 第7章 7-3 図 7-1 保険料推移

カテゴリF 認知症施策推進計画（5問）

QF-1 【委員（一般住民代表）】 認知症基本法とは何か？なぜ町計画で対応が必要なのか？

A. 認知症基本法（正式名称：共生社会の実現を推進するための認知症基本法）は、認知症の人が尊厳を保持しつつ希望を持って暮らすことができる社会の実現を目的として、令和6年1月1日に施行された法律です。第14条で、市町村に対し市町村認知症施策推進計画の策定を努力義務として規定しています。この計画は、（1）単独計画として策定するか、（2）既存の介護保険事業計画等に内包するかを選択でき、本町では後者（本計画第6章として内包）を採用しました。これにより、認知症施策と既存の高齢者施策との一体的な推進が可能となります。

【根拠データ】 認知症基本法（令和5年6月公布・令和6年1月施行）、第14条市町村計画策定の努力義務

【関連資料】 計画素案v1.5 第6章 6-1、認知症基本法本文

QF-2 【医療関係者・包括センター】 チームオレンジとは何か？なぜ整備するのか？

A. チームオレンジは、認知症サポーター（基礎研修修了者）のうち、ステップアップ研修を修了したメンバーで構成される、認知症の人本人と家族を継続的に支援するチーム組織です。本町では現在まだ整備されておらず、第10期計画で重点施策J-2として新規整備を進めます。具体的には、（1）既存のキャラバンメイト73名から認知症地域支援推進員と連携してチーム員を養成、（2）認知症の人本人・家族からのSOSに対応する地域支援活動を実施、（3）認知症カフェ「喫茶みかん」・本人ミーティング（新設）・初期集中支援チームと連携、を想定しています。

【根拠データ】 認知症基本法第15条（普及啓発）、認知症サポーター累計550名、キャラバンメイト累計73名

【関連資料】 計画素案v1.5 第6章 6-3 J-2、第1回委員会資料 協議事項4

QF-3 【委員】 認知症本人ミーティングとは具体的に何をするのか？

A. 認知症本人ミーティングは、認知症の人本人が中心となって自らの体験や希望を語り合う場で、認知症基本法第17条（社会参加の機会の確保）に対応する取組です。本町では認知症カフェ「喫茶みかん」を基盤に、ミーティング機能を加える形で新設します。具体的活動は、（1）月1回程度の本人交流会（家族・支援者は別室で待機）、（2）本人視点での施策への意見聴取（年1-2回）、（3）地域住民へのメッセージ発信（本人による講演等）、を想定しています。本人意見の収集は計画策定への反映だけでなく、本人主体のまちづくりへとつなげます。

【根拠データ】 認知症基本法第3条（本人の意思の尊重）、第17条（社会参加機会の確保）、認知症カフェ「喫茶みかん」を基盤

【関連資料】 計画素案v1.5 第6章 6-3 J-3、第1回委員会資料 協議事項4

QF-4 【委員】 認知症本人・家族への意見聴取はどのように実施するのか？

A. 本計画策定にあたっては、3つのチャネルで本人・家族意見を聴取します。第1に、地域包括支援センター経由（職員が本人・家族と直接対話、年2-3回）。第2に、国保川崎病院経由（認知症診療を受けている方への聴取依頼）。第3に、認知症カフェ「喫茶みかん」での参加者対話。なお、郵送アンケート（一般高齢者ニーズ調査・認定者調査）でも認知症関連設問を設けていますが、認知症の進行段階によって書面回答が困難な場合があるため、対面・代行記入での補完を重視します。聴取結果は計画素案Ver.2.0以降に反映します。

【根拠データ】 認知症基本法第14条第6項（本人・家族意見の反映）、包括センター・国保川崎病院・認知症カフェの3チャネル

【関連資料】 計画素案v1.5 第6章 6-1 川崎町の対応方針

QF-5 【民生委員・有識者】 **認知症サポーター累計550名（人口の約12.5%）は十分か？**

A. 本町の人口4,381人（R7.6推計）に対し、認知症サポーター累計550名は人口比約12.5%、第1号被保険者比約17%で、宮城県平均（推定10-12%）を上回る水準です。ただし、（1）量的拡大だけでなく質的向上（ステップアップ研修・チームオレンジ化）が重要、（2）企業・学校サポーター（小中学校・町内企業）の拡大余地、（3）養成講座の継続実施で減少分を補完、の3点が課題です。第10期では「累計サポーター数」（アウトプット）に加え「認知症本人と家族の地域生活満足度」（アウトカム）をKPIとして設定し、量より質の評価を強化します。

【根拠データ】 認知症サポーター累計550名（人口4,381人比約12.5%）、キャラバンメイト73名、宮城県平均は10-12%程度

【関連資料】 計画素案 v1.5 第6章 6-3 J-1、第3章 3-2-6

カテゴリ G 推進体制・評価（3問）

QG-1 【委員長】 PDCA サイクルの具体的な運営方法は？

A. 本計画ではPDCAサイクルにより毎年度進捗を確認します。Plan（計画期間開始前の事業計画・予算編成・KPI目標値設定）、Do（計画期間中の各施策・事業の実施）、Check（毎年度末のKPI進捗確認・事業実績評価・改善点抽出）、Action（次年度への改善反映・必要に応じた計画修正）の4段階を、町担当課・地域包括支援センター・関係機関で連動して運営します。中間評価として令和10年度に2年目評価を実施し、計画見直しの要否を検討します。最終評価は令和11年度末に実施し、第11期計画への引継ぎ材料とします。

【根拠データ】 計画期間令和9-11年度（3年間）、中間評価R10年度、最終評価R11年度末

【関連資料】 計画素案 v1.5 第8章 8-2

QG-2 【委員・住民代表】 パブリックコメントはいつ・どのように実施するか？

A. パブリックコメントは令和9年2月に約30日間実施を予定しています。実施方法は、（1）町ホームページへの計画素案掲載と意見投稿フォーム、（2）町広報誌での周知、（3）町役場・保健福祉課窓口・地域包括支援センターでの計画素案閲覧・意見記入様式の配置、です。意見集約後、町担当課と弊社で意見への対応案を作成し、計画書最終版に反映します。意見の主旨と対応結果は町ホームページで公表します。具体的な実施要領は第3回策定委員会で別途ご審議いただきます。

【根拠データ】 パブリックコメント期間 R9.2 の 30 日間（予定）、3月議会上程 R9.3、計画書公表 R9.3-4

【関連資料】 計画素案 v1.5 第8章 8-3、別添『作業チェックリスト v2.0』Phase 4

QG-3 【委員】 計画の評価は具体的にどう行うのか？ KPI 達成しなかった場合は？

A. 計画の評価は3階層で行います。第1階層は施策レベル（5基本目標×各重点施策）、第2階層は事業レベル（個別事業の実施回数・対象者数等）、第3階層はKPIレベル（数値目標の達成度）です。毎年度末の評価結果は本委員会の後継機関（仮称：高齢者保健福祉計画推進委員会）に報告します。KPI未達成の場合は、（1）原因分析（外部要因・内部要因の特定）、（2）改善策の検討（事業の重点化・新規施策の追加）、（3）必要に応じた目標値の修正、を行います。なお、KPIは「最低達成水準」ではなく「目指す姿」として設定し、未達成イコール失敗とは扱いません。

【根拠データ】 計画期間3年間×3階層評価、毎年度末PDCAサイクル、認知症施策は3層KPI（プロセス・アウトプット・アウトカム）

【関連資料】 計画素案 v1.5 第8章 8-3、第6章 6-3 KPI3層構造

カテゴリ H 川崎町固有論点（4問）

QH-1 【町内有識者】 国保川崎病院の役割は？ 広域医療連携でどう位置付けるか？

A. 国保川崎病院は町内唯一の医療拠点として、本計画では3つの役割を担います。第1に、町内住民の日常診療（外来・在宅医療）の中核拠点。第2に、広域医療機関（みやぎ県南中核病院・刈田総合病院・仙台市内）への紹介ハブ機能。第3に、認知症診療では認知症疾患医療センターと連携した早期発見・治療フォーロ。在宅医療・介護連携推進事業では、国保川崎病院＋包括センター＋ケアマネ＋訪問看護のネットワークが中核となります。経営面では町立病院として独立採算が課題ですが、地域医療継続の観点から維持・強化の方向で町と協議しています。

【根拠データ】 国保川崎病院（町立・町内唯一医療拠点）、認知症基本法第18条（保健医療福祉提供体制）

【関連資料】 計画素案 v1.5 第2章 2-5、第5章 5-3、第6章 6-3 J-5

QH-2 【社会福祉協議会】 ユニバーサルサポーター制度の特徴は？ 他自治体との違いは？

A. ユニバーサルサポーター制度は川崎町独自の住民主体の地域支援人材システムで、介護予防サロン・スマイル・レクリエーション・傾聴・生活支援・ふれあいネットワーク等14種別約400名のサポーターが登録しています。他自治体の認知症サポーター制度と比較した特徴は、（1）認知症だけでなく介護予防全般を対象、（2）種別ごとに専門分化、（3）社協運営で地域包括支援センター・町・民生委員と連携、です。第10期では量的拡大より質的向上（研修体系の整備・サポーター間連携の強化）に重点を置きます。本制度は住民主体地域づくりの中核と位置付けられます。

【根拠データ】 ユニバーサルサポーター 14種別約400名（介護予防サロン84・スマイル40・レク29・傾聴24・SC25・ふれあいNW145等）

【関連資料】 計画素案 v1.5 第2章 2-5、第3章 3-2-1、第5章 5-1

QH-3 【包括センター職員・委員】 地域包括支援センターの体制強化はどう進めるか？（現状3+1=4名）

A. 地域包括支援センターは社会福祉法人川崎町社会福祉協議会が運営し、現在保健師3名＋認定調査員1名の体制ですが、認定調査員1名での対応が業務量過多となっており、ケアプラン外部委託で運用しています。第10期では3点で体制強化を進めます。第1に、認定調査員の増員検討（町と協議）。第2に、業務効率化（ICT導入・申請オンライン化）。第3に、サポーター・民生委員等の地域人材連携強化（一次相談を地域で受け、複雑事案を包括が担当）。なお、増員は予算措置が必要なため、町担当課と継続協議します。

【根拠データ】 地域包括支援センター職員保健師3＋認定調査1＝4名（社協運営）、ケアプラン外部委託あり

【関連資料】 計画素案 v1.5 第2章 2-5、第3章 3-2-5、第5章 5-5

QH-4 【民生委員】 高齢者世帯エアコン購入支援（R7.10新設）はどんな制度か？

A. 本支援は令和7年10月に新設された川崎町独自の制度で、低所得高齢者世帯のエアコン購入・設置費用を一定額補助するものです。背景には、近年の夏季猛暑による熱中症リスクの高まり、独居・高齢夫婦世帯の増加、低所得世帯ではエアコン未設置・故障時の更新が困難という実態があります。具体的な対象要件・補助上限額・申請手続は町担当課にお問い合わせください。本計画では基本目標2の独自施策として位置付け、紙おむつ等支給事業・透析患者通院交通費助成と並ぶ「川崎町ならではのきめ細やかな高齢者支援」として記載します。

【根拠データ】 高齢者世帯エアコン購入支援 R7.10新設、川崎町独自施策、紙おむつ等支給・透析助成と並ぶ

【関連資料】 計画素案 v1.5 第3章 3-2-2、第5章 5-2

補遺：質問への対応原則

想定外の質問・反対意見が出た場合の対応原則を以下に整理します。

■ 想定外質問への対応

- ① 即答困難な質問は無理に回答せず、「お持ち帰り検討」とし、第2回委員会で書面回答する旨を委員に伝える。
- ② 数値データが手元にない場合は「町担当課に確認の上、回答する」と返答する。
- ③ 政策判断に関する質問（特に町長・議会判断事項）は「町としての検討事項」とし、断定的な回答は避ける。
- ④ 他自治体との比較を求められた場合は、見える化システム等の公式データを参照することを明示する。

■ 反対意見への対応

- ① 委員の意見は基本的に「ご意見」として受け止め、計画素案への反映可否を後日検討する形にする。
- ② 賛否が分かれる事項（協議事項1-5）は、複数意見を併記し、第2回委員会で再協議する。
- ③ 町方針と異なる意見でも、頭から否定せず「ご指摘の観点も踏まえて検討します」と受け止める。
- ④ 感情的な意見・住民個人の不満に対しては、傾聴の姿勢を保ち、個別相談として後日対応する。

■ 委員会運営のコツ

- ① 重要な協議事項（事項1-5）は時間を意識して進行する。1事項あたり5-8分が目安。
- ② 発言の少ない委員には事務局から指名・呼び水的な質問で発言を促す。
- ③ 次回までの宿題（書面回答・追加検討）は最後にまとめて確認する。
- ④ 議事録は要点筆記とし、確定版は委員確認後に町担当課で承認・公表する。

本想定問答集の運用：委員会開始前に町担当・事務局で15分程度の打合せをし、想定問答の流れを確認することを推奨します。
